診所論文摘要

2026年11月12日朝早簡報

五篇同行評審研究的中文摘要

這份合集把今日五篇論文改寫成繁體中文摘要，並附官方全文連結，方便在表格中直接打開閱讀。本稿並非論文全文，亦不是出版社官方譯本；訂閱期刊只能連到摘要或出版社頁面。

編號	題目	取用
01	針灸改善輕至中度抑鬱症狀及前額葉皮質功能：假針對照隨機試驗與近紅外腦功能成像研究	需訂閱
02	頰針改善中度抑鬱患者的抑鬱及焦慮症狀：三臂隨機對照試驗與功能磁力共振研究	需訂閱
03	間接灸改善精神分裂症患者的失眠及相關症狀：隨機對照試驗	公開全文
04	針灸相關療法治療中風後輕度認知障礙：系統回顧與網絡 Meta 分析	公開全文
05	血府逐瘀口服液輔助治療穩定型心絞痛：多中心雙盲安慰劑對照隨機試驗	公開全文

公開全文：第 03 篇可經 PMC 閱讀；第 04、05 篇可經 Frontiers／Europe PMC 閱讀。第 01、02 篇為訂閱期刊，本 PDF 只提供中文摘要與官方連結。

今日論文 • 第 01 篇 需訂閱／付費

針灸改善輕至中度抑鬱症狀及前額葉皮質功能：假針對照隨機試驗與近紅外腦功能成像研究

Acupuncture improves depressive symptoms and prefrontal cortical function in mild to moderate depressive disorder: A randomized sham-controlled trial and fNIRS study

作者 Yang B, Wang T, Zhu F, Liu Y, Li Z, Luo L, Yin L, Mao S, Wu J, Miao R 等

期刊 Neuropharmacology（2026年11月15日；線上／刊物資料）

識別碼 PMID 42379469 • DOI 10.1016/j.neuropharm.2026.111088

取用 需訂閱／付費

官方連結（點擊即可打開）

- PubMed 摘要 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/42379469/
- DOI（出版社全文，可能需訂閱） https://doi.org/10.1016/j.neuropharm.2026.111088

研究是什麼

這是一項針對輕至中度抑鬱障礙的隨機、假針對照臨床試驗，並以功能性近紅外光譜（fNIRS）觀察前額葉皮質激活與功能連接，探討針灸改善情緒症狀的可能神經機制。

方法要點

- 患者隨機分為真針組（RA）或假針組（SA），接受為期 8 周的標準化治療。
- 臨床結果包括抑鬱自評量表（SDS）、焦慮自評量表（SAS）、生活質素量表 SF-36，以及中醫證候積分。
- 部分受試者接受靜息態及任務態 fNIRS，評估前額葉激活與功能連接。
- 摘要未列明總樣本量及具體分數差值，解讀時須保留此限制。

主要結果

- 與基線相比，真針組 SDS、SAS 顯著下降，SF-36 情緒相關範疇顯著改善。
- 效果自第 4 周出現，治療結束後可持續至 12 周；真針組改善幅度較假針組更大、亦較穩定。
- fNIRS 顯示真針後背外側及內側前額葉激活增強、前額葉功能連接加強；假針組神經改變有限。
- 作者認為，調節前額葉激活與連接，可能是針灸抗抑鬱效應的機制之一。

中醫診所臨床啟示

- 輕至中度抑鬱或伴隨焦慮的門診患者，若藥物反應不佳或難以耐受，可將針灸作為輔助選項討論。
- 必須先排除急重症、雙相情感障礙及自殺風險，並與精神科或家庭醫生協調，不可取代必要藥物或心理治療。
- 向患者說明：目前公開摘要未提供樣本量及精確分差，證據仍須對照全文後再作判斷。

限制與解讀注意

- 樣本量及具體效應量未在摘要列出。
- 假針對照設計有助減低安慰劑效應，但針灸試驗難以完全致盲。
- fNIRS 只覆蓋皮質淺層，不能直接推論深部腦區改變。

> 聲明：這份 PDF 由新聞bot 根據已核實的摘要及（如屬公開取用）論文頁面撰寫中文摘要，方便診所快速閱讀，並非出版社官方譯本，亦不是論文全文。關鍵數據請以官方全文為準。本摘要供專業參考，不能代替個別患者的臨床判斷。

今日論文 ・ 第 02 篇 需訂閱／付費

頰針改善中度抑鬱患者的抑鬱及焦慮症狀：三臂隨機對照試驗與功能磁力共振研究

Cheek acupuncture can improve the depressive and anxious symptoms of patients with moderate depression disorders

作者 Jia X, Shen P, Wang C, Zhou G, Zhou H, Xu F, Jiang S

期刊 Complementary Therapies in Medicine（2026年8月）

識別碼 PMID 42128035 ・ DOI 10.1016/j.ctim.2026.103383

取用 需訂閱／付費

官方連結（點擊即可打開）

- PubMed 摘要 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/42128035/
- DOI（出版社全文，可能需訂閱） https://doi.org/10.1016/j.ctim.2026.103383

研究是什麼

單中心三臂隨機對照試驗，比較真頰針、假頰針與口服舍曲林，對中度抑鬱患者 HAMD-17、HAMA 的影響，並以 fMRI 觀察真頰針組治療前後的局部一致性（ReHo）改變。

方法要點

- 浙江中醫藥大學附屬醫院針灸科及精神衛生科門診招募（2022年9月至2025年5月），系統隨機分為頰針組（AC）、假頰針組（SAC）及藥物組。
- 頰針取頭點（CA-1）、頸點（CA-5）、上焦（CA-2）、中焦（CA-3）、下焦（CA-4），約刺入 5–7.5 mm，不作補瀉，共 10 針，留針 30 分鐘。
- 假頰針取真穴向身體前正中線旁開 10 mm，用鈍頭針不刺入皮膚。每周 3 次，共 12 周、36 次。藥物組口服舍曲林。
- 於基線及治療後第 1、2、3、4、8、12 周及治療結束後 2 個月評估 HAMD-17、HAMA；僅頰針組接受治療前後 fMRI。摘要未列樣本量及具體分差。

主要結果

- 三組治療後 HAMD-17、HAMA 均較基線顯著下降（P<0.001），均可改善中度抑鬱的抑鬱及焦慮症狀。
- 作者報告頰針組療效優於假針組及藥物組；三組均約自第 2 周起效（藥物組焦慮改善約自第 3 周）。
- 頰針組分數由第 3 至第 8 周持續下降，其後進入平台，治療後 2 個月隨訪仍維持；假針及藥物組改善主要見於早期，後期較趨穩定。
- fMRI：治療後左側額中回（L-MFG）ReHo 下降，左側額上回（L-SFG）ReHo 上升，作者推測與情緒、認知控制回路重塑有關。

中醫診所臨床啟示

- 中度抑鬱門診可將頰針作為輔助討論，但對「優於舍曲林」的結論須審慎：藥物組無法像針灸那樣雙盲，優效可能受期望效應影響。
- fMRI 只在真頰針組進行，並無假針或藥物對照影像，不能單獨證明特異性機制。
- 嚴重抑鬱、自殺風險、精神病性症狀或需急性處理者，必須轉介西醫精神科，不可延遲。

限制與解讀注意

- 單中心；摘要未提供樣本量及精確分差。
- 藥物對照未致盲；影像只覆蓋真針組。
- 結果尚待全文核對及獨立重複。

> 聲明：這份 PDF 由新聞bot 根據已核實的摘要及（如屬公開取用）論文頁面撰寫中文摘要，方便診所快速閱讀，並非出版社官方譯本，亦不是論文全文。關鍵數據請以官方全文為準。本摘要供專業參考，不能代替個別患者的臨床判斷。

今日論文 • 第 03 篇 公開全文

間接灸改善精神分裂症患者的失眠及相關症狀：隨機對照試驗

Indirect moxibustion therapy improves insomnia and associated symptoms in patients with schizophrenia

作者 Cai J, Wu M, Zhang J

期刊 Trials 第 27 卷第 1 期（2026年7月29日）

識別碼 PMID 42928360 • PMC13700130 • DOI 10.1186/s13063-026-09915-w

取用 公開全文

官方連結（點擊即可打開）

- PubMed https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/42928360/
- DOI／期刊頁 https://doi.org/10.1186/s13063-026-09915-w
- PMC 公開全文 https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC13700130/

研究是什麼

單中心隨機對照試驗，評估在低劑量右佐匹克隆（dexzopiclone）基础上，加用間接灸（IM）對比假間接灸（SIM），對精神分裂症共病失眠患者睡眠質素（PSQI）及生活質素（SQLS）的影響。

方法要點

- 共 120 人，隨機分為間接灸組與假灸組各 60 人，標準化干預 8 周。
- 兩組均同時使用低劑量助眠藥；倫理審查來自上海市精神衛生中心（SMHC-IRB-2023-08），試驗註冊號 NCT06171308。
- 主要比較治療第 4、8 周 PSQI 及 SQLS 相對於基線的組間校正差值。

主要結果

- 基線 PSQI、SQLS 兩組相若。第 4 及第 8 周，間接灸組分數均顯著低於假灸組。
- PSQI：第 4 周 10.10±1.76 對 13.50±1.65；第 8 周 10.65±1.54 對 12.77±2.05。組間校正差第 4 周 −3.399（95% CI −4.078 至 −2.719），第 8 周 −2.115（95% CI −2.795 至 −1.435）；均 P<0.001。
- SQLS：組間校正差第 4 周 −6.801，第 8 周 −7.732（95% CI −10.071 至 −5.393）；均 P<0.001。
- 作者認為改善具統計及臨床意義，但屬初步結果，需要多中心、更長期、更豐富終點的試驗驗證。

中醫診所臨床啟示

- 已在精神專科穩定用藥、仍有失眠的精神分裂症患者，間接灸或可作輔助，但必須與精神科協調。
- 不可自行減停抗精神病藥或助眠藥；兩組皆同時使用低劑量右佐匹克隆，結果反映的是「加用間接灸」而非單用艾灸取代藥物。
- 結果不能外推至無精神病診斷的一般失眠，亦不能外推至急性精神症狀未穩者。

限制與解讀注意

- 單中心；隨訪僅 8 周。
- 假灸難以完全致盲；擴充結局指標及長期安全性仍不足。

聲明：這份 PDF 由新聞bot 根據已核實的摘要及（如屬公開取用）論文頁面撰寫中文摘要，方便診所快速閱讀，並非出版社官方譯本，亦不是論文全文。關鍵數據請以官方全文為準。本摘要供專業參考，不能代替個別患者的臨床判斷。

今日論文 ・ 第 04 篇 公開全文

針灸相關療法治療中風後輕度認知障礙：系統回顧與網絡 Meta 分析

Integrative approaches to acupuncture therapies for post-stroke mild cognitive impairment: a systematic review and network meta-analysis

作者 Huang S-L, Hui Y-Y, Zhang W, Tang X, Peng F, Liu Z-Y, Zheng H, Zhai Y

期刊 Frontiers in Neurology（2026年11月2日）

識別碼 DOI 10.3389/fneur.2026.1954073 ・ PROSPERO CRD420251165945

取用 公開全文

官方連結（點擊即可打開）

- Frontiers 公開全文 https://www.frontiersin.org/journals/neurology/articles/10.3389/fneur.2026.1954073/full
- DOI https://doi.org/10.3389/fneur.2026.1954073

研究是什麼

針對中風後輕度認知障礙（PSMCI）的系統回顧與網絡 Meta 分析，比較多種針灸及針灸聯合療法在 MoCA、MMSE、Barthel 指數及總有效率上的相對效果與安全性，避免把不同程度的中風後認知障礙混為一談。

方法要點

- 檢索九個資料庫及四個試驗註冊平台，截至 2025 年 10 月。納入中、英文 RCT；以 Cochrane RoB 2 評估偏倚，CINeMA／GRADE 評估證據可信度。
- 最終納入 47 項 RCT、3,680 名患者、約 15 類針灸相關介入。幾乎全部研究在中國進行，多數以中文發表。
- 常用穴位頻率較高者包括百會（DU20）、神庭（DU24）、四神聰（EX-HN1）、風池（GB20）、神門（HT7）。

主要結果

- 成對 Meta：針灸聯合常規治療，一般較單一干預更能改善認知。例如電針＋認知訓練改善 MoCA 優於單用認知訓練（5 項 RCT，MD 2.49，95% CI 1.60–3.38）。
- 網絡 Meta（須在相應網絡內解讀）：改善 MoCA 及總有效率，電針＋艾灸排名較前（相對認知訓練，MoCA MD 5.42，95% CI 2.10–8.74；SUCRA 約 94.6%）。
- 改善 MMSE：電針＋高壓氧、毫針＋重複經顱磁刺激較前。改善 Barthel：毫針＋多奈哌齊（MD 8.67，95% CI 5.47–11.88）、電針＋認知訓練較前。
- 13 項研究報告不良事件，多為輕微皮下血腫、暈針、頭暈或惡心，未見嚴重事件組間明顯增加。
- 證據質量參差：47 項中 8 項整體高偏倚風險、10 項低風險、29 項存在疑慮。MoCA 比較的可信度多數為低至中等，僅兩項比較評為高。

中醫診所臨床啟示

- 中風後記憶或認知輕度下降的康復門診，針灸（尤其電針配合艾灸，或針灸配合認知訓練）可作輔助討論，並與神經科、康復科並行。
- SUCRA 排名只供參考，不能當成「最佳方案」；部分網絡互不連通，不同子網絡的排名不可直接對比。

- 須向患者及家屬說明：多數試驗方法學質量有限、幾乎全在中國進行，外推須謹慎；不能取代急性中風或痴呆的標準評估。

限制與解讀注意

- 納入研究偏倚風險高、異質性大，部分比較證據等級很低。
- 幾乎全為中國試驗，外部效度有限；MMSE、Barthel 形成互不連通的子網絡。
- 作者亦指出針刺手法、劑量參數報告不足，影響可重複性。

聲明：這份 PDF 由新聞bot 根據已核實的摘要及（如屬公開取用）論文頁面撰寫中文摘要，方便診所快速閱讀，並非出版社官方譯本，亦不是論文全文。關鍵數據請以官方全文為準。本摘要供專業參考，不能代替個別患者的臨床判斷。

今日論文 • 第 05 篇 公開全文

血府逐瘀口服液輔助治療穩定型心絞痛：多中心雙盲安慰劑對照隨機試驗

Effects of Xuefu Zhuyu oral liquid as adjunctive treatment for stable angina: a randomized controlled trial

作者 Cao W, Liao S, Zhou L, Li G, Jiang J, Lv W, Dong B, Liu L, Zhang J, Wang Y, Ouyang W, Du Y, Wen Z 等

期刊 Frontiers in Medicine（2026年4月29日）

識別碼 DOI 10.3389/fmed.2026.1787481 • 註冊號 ChiCTR1900026899

取用 公開全文

官方連結（點擊即可打開）

- Frontiers 公開全文 https://www.frontiersin.org/journals/medicine/articles/10.3389/fmed.2026.1787481/full
- Europe PMC 公開 PDF https://europepmc.org/articles/PMC13167926?pdf=render
- DOI https://doi.org/10.3389/fmed.2026.1787481

研究是什麼

在中國六間醫院進行的多中心、隨機、雙盲、安慰劑對照試驗，評估血府逐瘀口服液（XZOL）作為標準抗心絞痛治療的輔助用藥，對穩定型心絞痛（氣滯血瘀證）疼痛強度的療效與安全性。第一作者單位包括香港浸會大學中醫藥學院。

方法要點

- 納入 30–75 歲、符合穩定型心絞痛及氣滯血瘀證、CCS I–III 級、有冠狀動脈疾病客觀證據、每周至少兩次發作、入組前兩周疼痛 VAS ≥3 分的患者。
- 2020年6月至2022年6月篩選 263 人，隨機 152 人；全分析集（FAS）148 人，兩組各 74 人。加於常規抗心絞痛治療，XZOL 或外觀、味道匹配的安慰劑，每次 20 mL、每日三次，共 12 周，再隨訪 12 周。
- 主要終點：第 12 周平均心絞痛疼痛 VAS（10 cm）相對基線的改變。次要終點包括第 24 周 VAS、發作頻率及持續時間、急救硝化甘油使用、CCS 分級、證候、西雅圖心絞痛問卷、EQ-5D-5L 及 PSQI。

主要結果

- 第 12 周 FAS：XZOL 組 VAS 多降 0.63 分（校正差 −0.63，95% CI −1.12 至 −0.14；P=0.012）。第 24 周仍見差距（−0.47，95% CI −0.94 至 −0.002；P=0.049）。符合方案集（PPS）效應更大（第 12 周 −1.11）。
- 急救硝化甘油使用率：第 12 周 2.7% 對 13.5%（P=0.016）；第 24 周 2.7% 對 12.2%（P=0.029）。發作頻率、持續時間、CCS、生活質素等其餘次要終點組間大多無統計學差異。
- 作者預先設定的優效界值為 1.7 分，實際 FAS 效應未達此界值，整體止痛幅度屬中等偏小。CCS III 級亞組可能得益較明顯，但人數少，僅供參考。
- 不良事件兩組均為 10.5%。XZOL 組有 1 例不穩定心絞痛，監察委員會判定與試驗藥物無關；1 例肝功能異常被視為可能相關，經處理後完成試驗。

中醫診所臨床啟示

- 氣滯血瘀型胸痹、穩定型心絞痛患者，可將血府逐瘀口服液作為輔助討論，但須維持原有西藥及心臟科隨訪，不能取代抗心絞痛藥或血運重建評估。
- 向患者如實說明：止痛幅度不大，未達到試驗預設的 1.7 分優效界值；較明確的是急救硝化甘油使用減少。
- 急性胸痛加重、氣促、出冷汗、疼痛放射或症狀性質改變，須即時轉急症。此研究與 11-11 簡報的痛經試驗為同一成藥、不同適應症，不可互相套用結論。

限制與解讀注意

- 主要終點為主觀 VAS，安慰劑組亦有明顯改善；試驗在疫情期間進行，完成隨訪人數少於隨機人數。
- 中藥口味難以完全致盲；只納入中國氣滯血瘀證患者，外推有限。
- 未以運動耐量或心肌灌注等客觀功能指標作為主要終點。

聲明：這份 PDF 由新聞bot 根據已核實的摘要及（如屬公開取用）論文頁面撰寫中文摘要，方便診所快速閱讀，並非出版社官方譯本，亦不是論文全文。關鍵數據請以官方全文為準。本摘要供專業參考，不能代替個別患者的臨床判斷。